# प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत

Principles of Primary Health Care

## प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा की संकल्पना

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा (**Primary Health Care**) स्वास्थ्य के लिए ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है जो आवश्यक देखभाल को लोगों के दैनिक जीवन के निकट लाता है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोग की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल के साथ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियों पर कार्य शामिल है।

इसका उद्देश्य केवल रोगी को दवा देना नहीं, व्यक्ति, परिवार और समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सेवा तथा सहयोग उपलब्ध कराना है। लोगों की जरूरत, समान पहुँच और भागीदारी इसकी दिशा तय करते हैं।

## आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल

अल्मा-अता की संकल्पना में ऐसी देखभाल पर बल है जो व्यावहारिक, वैज्ञानिक आधार वाली, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और समुदाय तथा देश के लिए वहनीय हो। लोग योजना और कार्य में सक्रिय भाग लें तथा आत्मनिर्भरता बढ़े।

| प्रमुख पक्ष | अर्थ |
|---|---|
| लोगों के निकट सेवा | घर और कार्यस्थल से यथासंभव सुगम संपर्क |
| समग्र दृष्टिकोण | शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जरूरतों पर ध्यान |
| निरंतरता | जीवन के विभिन्न चरणों में संबंधित सेवाएँ |
| सहभागिता | परिवार और समुदाय की सक्रिय भूमिका |

> प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारभूत दिशा है; यह केवल किसी एक भवन या उपचार का नाम नहीं है।

# संबंधित अवधारणाओं में अंतर

Distinguishing Related Concepts

| अवधारणा | प्रमुख अर्थ |
|---|---|
| प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा (**Primary Health Care**) | सेवा, सामाजिक निर्धारक और समुदाय की व्यापक व्यवस्था |
| प्राथमिक देखभाल (**Primary Care**) | प्रथम संपर्क तथा व्यक्ति की सामान्य स्वास्थ्य जरूरतों की निरंतर देखभाल |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (**Primary Health Centre**) | भारत की सेवा व्यवस्था में एक प्रकार का स्वास्थ्य संस्थान |
| प्राथमिक रोकथाम (**Primary Prevention**) | रोग होने से पहले जोखिम और कारणों को कम करना |
| प्राथमिक चिकित्सा (**First Aid**) | बीमारी या चोट में तत्काल प्रारंभिक सहायता |

## एक जैसे शब्द, अलग अर्थ

टीकाकरण प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। स्थानीय केंद्र में जाँच, सामान्य उपचार और आगे की सेवा से संपर्क प्राथमिक देखभाल में आते हैं। इनके साथ सुरक्षित पानी और समुदाय की भागीदारी जोड़ने पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा दृष्टिकोण बनता है।

## PHC संक्षेप का संदर्भ

अंग्रेज़ी संक्षेप **PHC** का उपयोग **Primary Health Care** और **Primary Health Centre**, दोनों के लिए हो सकता है। वाक्य में सेवा की संकल्पना है या केंद्र की पहचान, यह देखकर अर्थ समझना चाहिए।

> प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का पूर्ण पर्याय नहीं है; दोनों का उद्देश्य और दायरा अलग है।

# अल्मा-अता और अस्ताना का ऐतिहासिक संदर्भ

Alma-Ata and Astana: Historical Context

## अल्मा-अता सम्मेलन

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 6 से 12 सितंबर 1978 तक अल्मा-अता, तत्कालीन सोवियत संघ, में आयोजित हुआ। यह नगर आज अल्माटी, कज़ाख़स्तान है। **WHO** और **UNICEF** ने सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित किया था। घोषणा 12 सितंबर 1978 से संबंधित है।

## सभी के लिए स्वास्थ्य

सभी के लिए स्वास्थ्य (**Health for All**) में लोगों को ऐसा स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करने का अवसर देना प्रमुख विचार था जिससे वे सामाजिक और आर्थिक जीवन में योगदान कर सकें। वर्ष 2000 उस समय की ऐतिहासिक लक्ष्य-समय सीमा थी; इसे उपलब्धि का प्रमाण नहीं समझना चाहिए।

## अस्ताना घोषणा

25 और 26 अक्टूबर 2018 को अस्ताना, कज़ाख़स्तान, में वैश्विक सम्मेलन हुआ। अस्ताना घोषणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा की प्रतिबद्धता को फिर बल दिया तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास से उसका संबंध स्पष्ट किया।

| घटना | प्रमुख महत्त्व |
|---|---|
| अल्मा-अता, 1978 | आवश्यक देखभाल, समानता और सहभागिता की दिशा |
| अस्ताना, 2018 | समकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था में प्रतिबद्धता का नवीनीकरण |

> घोषणा का ऐतिहासिक वर्ष और वेबसाइट पर दस्तावेज दोबारा प्रकाशित होने की तारीख अलग हो सकते हैं।

# अल्मा-अता की प्रमुख अवधारणाएँ

Key Ideas of the Alma-Ata Declaration

## स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय

स्वास्थ्य को मूल मानवीय अधिकार तथा सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण जरूरत माना गया। देशों के बीच और एक देश के अंदर स्वास्थ्य में बड़ी असमानता को दूर करने पर बल दिया गया।

## जनभागीदारी

लोग अपनी स्वास्थ्य देखभाल की योजना और कार्यान्वयन में भाग ले सकते हैं। समुदाय को केवल निर्देश पाने वाला समूह समझने से उसकी जानकारी और क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता।

## राष्ट्रीय व्यवस्था से संबंध

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास का अभिन्न भाग है। यह व्यक्ति, परिवार और समुदाय का स्वास्थ्य प्रणाली से प्रथम संपर्क सुगम करती है तथा आगे की देखभाल का रास्ता बनाती है।

## उपयोगी और टिकाऊ सेवा

- वैज्ञानिक आधार और व्यावहारिक कार्यविधि।
- सामाजिक स्वीकार्यता और लोगों की सक्रिय भागीदारी।
- सभी के लिए सुगम पहुँच और वहनीय लागत।
- स्थानीय तथा राष्ट्रीय संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग।

## व्यापक जिम्मेदारी

स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ कृषि, शिक्षा, जल, स्वच्छता, आवास और अन्य क्षेत्रों की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर स्वास्थ्य केवल अस्पताल के काम से नहीं प्राप्त होता।

> स्वास्थ्य का अधिकार, समान अवसर, जनभागीदारी और सामाजिक विकास अल्मा-अता की दिशा में जुड़े हुए विचार हैं।

# चार प्रमुख आधारभूत सिद्धांत

Four Fundamental Principles

## सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के आधारभूत सिद्धांतों को चार प्रमुख शीर्षकों में समझा जा सकता है। ये सेवा के वितरण, समुदाय की भूमिका, विभागों के सहयोग और उपयोगी तकनीक के चयन को दिशा देते हैं।

| सिद्धांत | केंद्रीय विचार | व्यवहार में उदाहरण |
|---|---|---|
| न्यायसंगत वितरण (**Equitable Distribution**) | जरूरत के अनुसार समान अवसर | दूरस्थ क्षेत्र तक सेवा पहुँचाना |
| सामुदायिक सहभागिता (**Community Participation**) | लोगों की सक्रिय भूमिका | स्थानीय स्वास्थ्य योजना में समुदाय |
| अंतरक्षेत्रीय समन्वय (**Intersectoral Coordination**) | विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग | स्वास्थ्य और जल विभाग का संयुक्त कार्य |
| उपयुक्त प्रौद्योगिकी (**Appropriate Technology**) | परिस्थिति के अनुसार वैज्ञानिक उपाय | सुरक्षित, उपयोगी और रखरखाव योग्य साधन |

## सिद्धांत और सेवाएँ

चार सिद्धांत बताते हैं कि काम किस दृष्टिकोण से किया जाए। आठ आवश्यक सेवा-घटक बताते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा में किन गतिविधियों को शामिल किया गया। दोनों सूचियाँ अलग प्रश्नों का उत्तर देती हैं।

## एक साथ उपयोग

किसी गाँव में पानी की समस्या का समाधान स्थानीय भागीदारी, जल विभाग के सहयोग, उपयुक्त जल व्यवस्था और वंचित परिवार तक पहुँच को साथ जोड़ता है।

> चार सिद्धांत केवल याद रखने की सूची नहीं; योजना और सेवा की समीक्षा के आधार हैं।

# न्यायसंगत वितरण और समान अवसर

Equitable Distribution and Equity

## न्यायसंगत वितरण का अर्थ

स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए उपलब्ध हो तथा जरूरत और बाधा के अनुसार अतिरिक्त सहयोग मिले। न्यायसंगत वितरण में धन, स्थान, सामाजिक स्थिति या पहचान के कारण सेवा से वंचित होने की समस्या कम की जाती है।

## समानता और न्यायसंगतता

| आधार | समान व्यवहार (Equality) | न्यायसंगत अवसर (Equity) |
|---|---|---|
| सहायता | सभी को एक जैसी व्यवस्था | अलग जरूरत के अनुसार उपयुक्त सहायता |
| उदाहरण | एक ही समय पर सेवा | कामकाजी या दूरस्थ समूह के लिए सुगम समय |
| उद्देश्य | एकरूपता | वास्तविक बाधा कम करके पहुँच |

## बाधाओं की पहचान

दूरी, यात्रा खर्च, भाषा, दिव्यांगता, काम का समय और भेदभाव सेवा तक पहुँच को प्रभावित कर सकते हैं। केवल केंद्र की उपस्थिति को सभी लोगों की बराबर पहुँच नहीं माना जाता।

## प्राथमिकता और गुणवत्ता

अधिक जरूरत वाले समूह को अतिरिक्त सहयोग देना अन्य लोगों की आवश्यक सेवा समाप्त करना नहीं है। सभी को गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले और अधिक बाधा वाले समूह तक पहुँचने के उपाय किए जाएँ।

## उदाहरण

दिव्यांग व्यक्ति के लिए सुगम प्रवेश तथा दूरस्थ परिवार के लिए रेफरल परिवहन न्यायसंगत सेवा के व्यावहारिक उपाय हैं।

> सेवा का मूल्यांकन उपलब्ध केंद्रों की संख्या के साथ उन लोगों से करें जो अभी भी सेवा से छूट रहे हैं।

# सामुदायिक सहभागिता

Community Participation

## सहभागिता की संकल्पना

सामुदायिक सहभागिता में लोग समस्या पहचानने, प्राथमिकता तय करने, योजना बनाने, कार्य करने और परिणाम की समीक्षा में भूमिका निभाते हैं। केवल बैठक में उपस्थित होना पूर्ण सहभागिता का प्रमाण नहीं है।

## सहभागिता के स्तर

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **समस्या पहचानना** | लोगों के अनुभव और छूटे समूह की जरूरत सुनना। |
| 2 | **निर्णय में भाग लेना** | प्राथमिकता तथा व्यावहारिक योजना तय करना। |
| 3 | **कार्य में सहयोग** | भूमिका, संसाधन और सेवा से संपर्क जोड़ना। |
| 4 | **समीक्षा करना** | परिणाम और अनुभव से आवश्यक सुधार। |

## स्थानीय अनुभव का महत्त्व

परिवार बता सकते हैं कि सेवा का समय सुविधाजनक है या नहीं, पानी कहाँ दूषित हो सकता है तथा किन समूहों तक जानकारी नहीं पहुँचती। यह ज्ञान योजना को अधिक व्यावहारिक बनाता है।

## समावेशी प्रतिनिधित्व

महिलाओं, युवाओं, वृद्ध व्यक्तियों और वंचित समूहों की आवाज शामिल होनी चाहिए। केवल प्रभावशाली व्यक्तियों की राय को पूरे समुदाय की जरूरत नहीं माना जा सकता।

## जिम्मेदारी का संतुलन

भागीदारी से स्थानीय क्षमता बढ़ती है, लेकिन इससे सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की सेवा संबंधी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। समुदाय को संसाधन, प्रशिक्षण और वास्तविक निर्णय का अवसर चाहिए।

> सहभागिता का आधार संवाद, निर्णय में भूमिका और समीक्षा है; केवल श्रमदान या उपस्थिति नहीं।

# अंतरक्षेत्रीय समन्वय

Intersectoral Coordination

## स्वास्थ्य के अनेक निर्धारक

पोषण, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, आय, आवास और कार्यस्थल की सुरक्षा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का कार्य अन्य क्षेत्रों से जोड़ना आवश्यक है।

| क्षेत्र | स्वास्थ्य में योगदान |
|---|---|
| जल और स्वच्छता | सुरक्षित पानी, शौचालय तथा अपशिष्ट व्यवस्था |
| शिक्षा | स्वास्थ्य जानकारी और विद्यालय में सुरक्षित वातावरण |
| कृषि और खाद्य व्यवस्था | भोजन की उपलब्धता और पोषण |
| महिला एवं बाल विकास | देखभाल, पोषण और विकास संबंधी सहयोग |
| स्थानीय प्रशासन | पर्यावरण तथा सार्वजनिक सुविधा का प्रबंधन |

## एकीकृत उदाहरण

बच्चों में बार-बार दस्त की समस्या हो तो केवल उपचार करना पर्याप्त नहीं है। पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा तक पहुँच की समीक्षा साथ चाहिए।

## समन्वय की प्रक्रिया

समस्या साझा करना, भूमिकाएँ तय करना, संसाधन जोड़ना और परिणाम की समीक्षा अंतरक्षेत्रीय कार्य के आधार हैं। केवल अलग विभागों का नाम लिख देने से समन्वय नहीं बनता।

## अन्य समन्वय से अंतर

दो स्वास्थ्य केंद्रों के बीच रेफरल स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर समन्वय है। स्वास्थ्य और जल विभाग का सहयोग अंतरक्षेत्रीय समन्वय का उदाहरण है।

> स्वास्थ्य समस्या के सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों पर कार्य करने के लिए कई क्षेत्रों की भागीदारी चाहिए।

# उपयुक्त प्रौद्योगिकी

Appropriate Technology

## उपयुक्तता के आधार

उपयुक्त प्रौद्योगिकी ऐसी वैज्ञानिक कार्यविधि या साधन है जो समस्या के लिए प्रभावी, सुरक्षित, स्वीकार्य और स्थानीय व्यवस्था में उपयोग तथा रखरखाव योग्य हो। उसकी लागत और संसाधन जरूरत भी ध्यान में रखी जाती है।

| चयन का आधार | आवश्यक विचार |
|---|---|
| वैज्ञानिक प्रभावशीलता | क्या उपाय जरूरत के लिए उपयोगी है? |
| सुरक्षा | क्या अनावश्यक नुकसान का जोखिम कम है? |
| स्वीकार्यता | क्या लोग और कार्यकर्ता उसे समझकर उपयोग कर सकते हैं? |
| वहनीयता | क्या पूरी सेवा और रखरखाव का खर्च टिकाऊ है? |
| स्थानीय क्षमता | क्या प्रशिक्षण, सामग्री और मरम्मत उपलब्ध हैं? |

## कम कीमत पर्याप्त नहीं

सस्ता लेकिन गलत परिणाम देने वाला साधन उपयुक्त नहीं है। महँगा उपकरण भी जरूरत, लाभ और संचालन क्षमता के अनुसार उपयुक्त हो सकता है। निर्णय केवल कीमत देखकर नहीं लिया जाता।

## उदाहरण

मान्य रक्तचाप उपकरण, उपयोग का सही प्रशिक्षण और नियमित रखरखाव एक उपयोगी व्यवस्था बनाते हैं। उपकरण खरीदकर रख देना अपने-आप प्रभावी स्वास्थ्य सेवा नहीं है।

## डिजिटल तकनीक

टेलीपरामर्श दूरी की बाधा कम कर सकता है, पर संपर्क, गोपनीयता, भाषा और जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्ष सेवा की व्यवस्था भी चाहिए।

> उपयुक्त तकनीक वैज्ञानिक गुणवत्ता को बनाए रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों से मेल खाती है।

# आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के तीन घटक

Three Components of Modern Primary Health Care

## व्यापक स्वास्थ्य दृष्टिकोण

आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा पूरे समाज की भूमिका पर बल देती है। इसमें संबंधित सेवाएँ, स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारक और लोगों का सशक्तीकरण एक साथ शामिल हैं।

| घटक | प्रमुख अर्थ |
|---|---|
| एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएँ (**Integrated Health Services**) | प्राथमिक देखभाल और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य |
| बहुक्षेत्रीय नीति और कार्रवाई (**Multisectoral Action**) | सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय निर्धारकों पर कार्य |
| सशक्त व्यक्ति और समुदाय (**Empowered Communities**) | भागीदारी, जानकारी और निर्णय की क्षमता |

## चार सिद्धांतों से संबंध

चार आधारभूत सिद्धांत कार्य की दिशा बताते हैं। आधुनिक तीन घटक उसी व्यापक दृष्टिकोण में सेवा, बहुक्षेत्रीय कार्रवाई और जनसशक्तीकरण को व्यवस्थित करते हैं। तीन और चार की संख्या अलग होने से दोनों ढाँचों में विरोध नहीं बनता।

## जीवन भर की जरूरत

व्यक्ति की जरूरत जन्म, बचपन, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था में बदलती है। स्वास्थ्य सेवा को जीवन के विभिन्न चरणों से संबंधित होना चाहिए।

## उदाहरण

मधुमेह की देखभाल में स्थानीय सेवा, भोजन और शारीरिक गतिविधि के लिए अनुकूल परिस्थिति तथा व्यक्ति का ज्ञान और निर्णय, तीनों उपयोगी हैं।

> प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का केंद्र व्यक्ति और समुदाय हैं; संस्था और कार्यक्रम उनके लिए साधन हैं।

# आठ आवश्यक सेवा-घटक

Eight Essential Elements

## अल्मा-अता में आवश्यक गतिविधियाँ

अल्मा-अता की दिशा में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा में कम-से-कम आठ प्रमुख सेवा-घटक शामिल किए गए। यह व्यापक न्यूनतम आधार है, सेवाओं की हमेशा के लिए बंद सूची नहीं।

| क्रम | आवश्यक घटक |
|---|---|
| 1 | प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं तथा उनकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में शिक्षा |
| 2 | खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण को बढ़ावा |
| 3 | सुरक्षित पानी की पर्याप्त उपलब्धता तथा मूल स्वच्छता |
| 4 | परिवार नियोजन सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल |
| 5 | प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण |
| 6 | स्थानीय स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण |
| 7 | सामान्य रोगों और चोटों का उपयुक्त उपचार |
| 8 | आवश्यक दवाओं की उपलब्धता |

## समग्र अर्थ

इन घटकों में शिक्षा, पोषण और पर्यावरण के साथ रोकथाम तथा उपचार शामिल हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को केवल रोग रोकथाम या केवल चिकित्सकीय उपचार तक सीमित नहीं किया जा सकता।

## बदलती जरूरत

मानसिक स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, वृद्ध देखभाल और उपशामक देखभाल जैसी जरूरतें आज के समग्र कार्य में महत्वपूर्ण हैं।

> आठ आवश्यक घटक, चार सिद्धांत और आधुनिक तीन घटक अलग अध्ययन-ढाँचे हैं।

# स्वास्थ्य शिक्षा

Health Education

## उद्देश्य

स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्या, जोखिम, उपलब्ध सेवा और उचित व्यवहार समझने में सहयोग देती है। समझने योग्य जानकारी के साथ संवाद और व्यवहार के लिए आवश्यक परिस्थिति जरूरी है।

## प्रमुख विषय

- स्थानीय स्वास्थ्य समस्याएँ और रोकथाम के उपाय।
- स्वच्छता, भोजन, सुरक्षित पानी और शारीरिक गतिविधि।
- मातृ-बाल स्वास्थ्य तथा समय पर सेवा का उपयोग।
- टीकाकरण, रोग संबंधी मिथक और सामाजिक भेदभाव।
- खतरे की स्थिति में उचित स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच।

## संवाद के आधार

| आधार | व्यावहारिक उपयोग |
| --- | --- |
| स्थानीय भाषा | सरल शब्द और परिचित उदाहरण |
| दोतरफा संवाद | लोगों की शंका तथा अनुभव सुनना |
| व्यवहार की सुविधा | जानकारी को उपलब्ध संसाधन से जोड़ना |
| समीक्षा | संदेश समझ में आया या नहीं, यह देखना |

## जानकारी और परिस्थिति

साबुन से हाथ धोने की जानकारी उपयोगी है। यदि पानी और साबुन उपलब्ध नहीं हैं तो व्यवहार में बदलाव कठिन होगा। शिक्षा के साथ संसाधन और पर्यावरण की बाधाओं पर भी कार्य चाहिए।

## सशक्तीकरण

सही जानकारी व्यक्ति को प्रश्न पूछने और अपने स्वास्थ्य निर्णय में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता देती है।

> स्वास्थ्य शिक्षा में समझ, संवाद और व्यवहार की सुविधा साथ महत्वपूर्ण हैं।

# खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण

Food Supply and Proper Nutrition

## पोषण का प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंध

भोजन की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता, परिवार में वितरण और रोग की स्थिति पोषण को प्रभावित करते हैं। केवल भोजन देने या केवल पोषण संबंधी भाषण से हर समस्या हल नहीं होती।

## कार्य की प्रमुख दिशा

| क्षेत्र | आवश्यक कार्रवाई |
|---|---|
| भोजन की उपलब्धता | स्थानीय और वहनीय खाद्य पदार्थों तक पहुँच |
| भोजन की गुणवत्ता | विविध तथा जरूरत के अनुरूप आहार |
| परिवार में देखभाल | आयु और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार भोजन |
| सेवा से संबंध | पोषण जोखिम की पहचान और उपयुक्त रेफरल |
| सामाजिक सहयोग | संबंधित सहायता और कार्यक्रमों से संपर्क |

## स्थानीय भोजन का उपयोग

स्थानीय अनाज, दाल, सब्जी, फल और अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उचित उपयोग की जानकारी उपयोगी है। परिवार की आय, आदत और संसाधन के अनुसार व्यवहार्य विकल्प समझाना चाहिए।

## रोग और पोषण

संक्रमण भोजन का सेवन और उपयोग प्रभावित कर सकता है; अपर्याप्त पोषण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए पोषण और स्वास्थ्य सेवा को साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है।

## अंतरक्षेत्रीय योगदान

कृषि, खाद्य व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा महिला-बाल विकास का सहयोग पोषण सुधार में उपयोगी है।

> पोषण सुधार में भोजन, देखभाल, सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य सेवा परस्पर जुड़े हैं।

# सुरक्षित पानी और मूल स्वच्छता

Safe Water and Basic Sanitation

## स्वास्थ्य की आधारभूत जरूरत

सुरक्षित पानी, स्वच्छता और अपशिष्ट का उचित प्रबंधन रोग के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण हैं। पानी का स्रोत सुरक्षित होने के साथ परिवहन, भंडारण और उपयोग भी सही होना चाहिए।

| कार्यक्षेत्र | ध्यान देने योग्य पक्ष |
|---|---|
| पानी की उपलब्धता | पर्याप्त मात्रा और सुगम पहुँच |
| पानी की गुणवत्ता | संदूषण का आकलन और उपयुक्त सुरक्षित व्यवस्था |
| घरेलू भंडारण | साफ, ढका पात्र और दूषण से बचाव |
| स्वच्छता | शौचालय, हाथ धोना और सुरक्षित मल-निपटान |
| पर्यावरण | नालियों तथा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन |

## उपचार और रोकथाम का संबंध

दस्त के रोगी को आवश्यक उपचार मिलना चाहिए। साथ ही बार-बार रोग होने के कारणों में पानी और स्वच्छता की समीक्षा भी जरूरी है। उपचार तथा पर्यावरण में सुधार एक-दूसरे के पूरक हैं।

## स्थानीय जिम्मेदारी

परिवार, समुदाय, जल विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिकाएँ स्पष्ट हों। तकनीकी समस्या के लिए योग्य जाँच और व्यवस्था चाहिए; केवल पानी साफ दिखना उसकी सुरक्षा का प्रमाण नहीं है।

## व्यापक शब्द

**WASH** का संबंध पानी, स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार से है। यह व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा है।

> सुरक्षित पानी की श्रृंखला स्रोत से उपयोग तक सुरक्षित रहनी चाहिए।

# मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

Maternal and Child Health and Family Planning

## निरंतर देखभाल

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में गर्भावस्था से प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि, नवजात और बच्चे की देखभाल तक संबंधित सेवाओं का महत्त्व है। जोखिम की पहचान और जरूरत पड़ने पर उच्चतर सेवा से संपर्क आवश्यक है।

| चरण | देखभाल की प्रमुख दिशा |
|---|---|
| गर्भावस्था | आवश्यक जाँच, जानकारी और जोखिम का आकलन |
| प्रसव | योग्य सेवा और सुरक्षित व्यवस्था |
| प्रसवोत्तर अवधि | माता तथा नवजात की जरूरतों की समीक्षा |
| शिशु और बाल्यावस्था | पोषण, टीकाकरण, वृद्धि और विकास |
| परिवार नियोजन | जानकारी, स्वैच्छिक निर्णय और उपयुक्त सेवा |

## परिवार का सहयोग

महिला को भोजन, आराम, जानकारी और समय पर सेवा में सहयोग चाहिए। उसकी राय और निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार की सुविधा के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

## परिवार नियोजन

संतान के बारे में सूचित और स्वैच्छिक निर्णय, गर्भनिरोध संबंधी परामर्श तथा आवश्यक सेवाएँ व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य का भाग हैं। किसी विकल्प को दबाव से स्वीकार कराना उचित नहीं है।

## सेवा की सीमा

जटिलता होने पर स्थानीय केंद्र के संसाधन पर्याप्त न हों तो समय पर रेफरल जरूरी है।

> मातृ-बाल स्वास्थ्य में नियमित सेवा, सम्मानपूर्ण व्यवहार और समय पर रेफरल साथ महत्वपूर्ण हैं।

# टीकाकरण और प्रतिरक्षण

Immunization

## प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा में स्थान

प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण आवश्यक सेवा-घटकों में शामिल है। यह रोग होने से पहले विशेष सुरक्षा देने वाली प्राथमिक रोकथाम का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

## सेवा के प्रमुख पक्ष

- लागू कार्यक्रम और आयु के अनुसार टीकों की जानकारी।
- सही व्यक्ति, सही टीका और निर्धारित प्रक्रिया।
- टीके की गुणवत्ता तथा शीत शृंखला (**Cold Chain**)।
- अभिलेख, अगली सेवा की जानकारी और छूटी सेवा से संपर्क।
- प्रतिकूल घटना की स्थिति में उचित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया।

## पहुँच में बाधाएँ

दूरी, कार्य का समय, गलत जानकारी और टीकाकरण के प्रति डर सेवा के उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। सम्मानपूर्वक संवाद और सुविधाजनक सेवा व्यवस्था दोनों उपयोगी हैं।

## टीका और पूर्ण सुरक्षा

टीके चयनित रोगों के जोखिम और गंभीरता कम करने में योगदान देते हैं। सभी रोगों से एक जैसी या पूर्ण सुरक्षा मान लेना सही नहीं है। अन्य आवश्यक रोकथाम उपाय भी महत्त्वपूर्ण रह सकते हैं।

## सामुदायिक सहयोग

स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिवार को जानकारी, अभिलेख और सेवा से संपर्क में सहायता देते हैं। टीका देने का तकनीकी कार्य प्रशिक्षित सेवा की जिम्मेदारी है।

> टीकाकरण में पहुँच, गुणवत्ता, उचित जानकारी और सेवा की निरंतरता साथ चाहिए।

# स्थानीय स्थानिक रोगों का नियंत्रण

Control of Locally Endemic Diseases

## स्थानिक रोग की संकल्पना

स्थानिक रोग (**Endemic Disease**) किसी क्षेत्र या जनसमूह में अपेक्षित स्तर पर नियमित रूप से मौजूद रहने वाला रोग है। इसका अर्थ यह नहीं कि उस क्षेत्र में हर व्यक्ति रोगी है या रोग नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

## क्षेत्र के अनुसार प्राथमिकता

कुछ क्षेत्रों में मलेरिया, फाइलेरियासिस या अन्य रोगों का जोखिम अधिक हो सकता है। स्थानीय रोग-स्थिति, पर्यावरण और उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्रवाई तय होती है।

| कार्रवाई | उद्देश्य |
|---|---|
| निगरानी | रोग की प्रवृत्ति और असामान्य वृद्धि पहचानना |
| रोकथाम | स्थानीय कारण तथा जोखिम कम करना |
| समय पर सेवा | जाँच और उपयुक्त उपचार तक पहुँच |
| पर्यावरण सुधार | संबंधित वाहक तथा प्रजनन परिस्थितियों पर कार्य |
| समुदाय से संवाद | जानकारी, सहभागिता और सेवा का उपयोग |

## प्रकोप से अंतर

किसी क्षेत्र में अपेक्षित स्तर से अधिक रोग होना प्रकोप या महामारी का संकेत हो सकता है। स्थानिकता और अचानक बढ़ोतरी अलग बातें हैं।

## समन्वय

स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला, निगरानी व्यवस्था तथा प्रशासन को आवश्यक जानकारी और कार्रवाई जोड़नी चाहिए।

> स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्षेत्र की वास्तविक रोग-स्थिति के अनुसार प्राथमिकता तय करता है।

# सामान्य रोगों और चोटों का उपचार

Treatment of Common Illnesses and Injuries

## प्रथम संपर्क का महत्त्व

सामान्य बीमारी या चोट में स्थानीय सेवा व्यक्ति का आकलन, आवश्यक प्रारंभिक देखभाल और आगे की जरूरत तय कर सकती है। सामान्य दिखने वाली शिकायत कभी गंभीर स्थिति से भी संबंधित हो सकती है।

## उपयुक्त उपचार

उपयुक्त उपचार का अर्थ योग्य आकलन के आधार पर सही सेवा देना है। हर व्यक्ति को एक जैसी दवा या हर बुखार में एंटीबायोटिक देना उचित कार्यविधि नहीं है।

| सेवा का पक्ष | आवश्यक कार्य |
|---|---|
| आकलन | शिकायत, जोखिम और स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा |
| स्थानीय देखभाल | उपलब्ध क्षमता के अनुसार उपयुक्त सेवा |
| जानकारी | उपयोग, देखभाल और अगली समीक्षा समझाना |
| खतरे की पहचान | गंभीरता होने पर त्वरित उच्चतर सेवा |
| अनुवर्ती संपर्क | सुधार और आगे की जरूरत की समीक्षा |

## क्षमता की सीमा

विशेषज्ञ जाँच, गंभीर चोट, जटिल प्रसव या अन्य उच्च जोखिम स्थिति में रेफरल की जरूरत हो सकती है। रेफरल करना कार्य की असफलता नहीं; सुरक्षित सेवा का भाग है।

## प्राथमिक चिकित्सा से संबंध

तत्काल प्रारंभिक सहायता और बाद का चिकित्सकीय उपचार अलग चरण हो सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था इनके बीच संपर्क बनाने में उपयोगी है।

> सही स्थानीय सेवा में उपचार के साथ अपनी सीमा पहचानना और समय पर रेफरल शामिल है।

# आवश्यक दवाओं की उपलब्धता

Provision of Essential Medicines

## आवश्यक दवाओं की संकल्पना

आवश्यक दवाएँ (**Essential Medicines**) जनसमूह की प्राथमिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चुनी जाती हैं। चयन में रोग की महत्ता, प्रभावशीलता, सुरक्षा और तुलनात्मक लागत-प्रभावशीलता जैसे आधार देखे जाते हैं।

## उपलब्धता के प्रमुख पक्ष

| पक्ष | आवश्यकता |
|---|---|
| चयन | प्राथमिक जरूरत और सेवा के स्तर के अनुसार सूची |
| गुणवत्ता | मान्य गुणवत्ता और सुरक्षित आपूर्ति |
| भंडारण | निर्धारित परिस्थिति और समाप्ति तिथि की निगरानी |
| निरंतर आपूर्ति | आवश्यक दवा समाप्त होने की समस्या कम करना |
| उचित उपयोग | सही व्यक्ति और उपयुक्त चिकित्सकीय निर्देश |

## दवा मिलना और सही उपयोग

दवा उपलब्ध होना पहला पक्ष है। उसका उचित चयन, मात्रा, उपयोग और समीक्षा भी आवश्यक है। दवा का नाम याद होना स्वयं उपचार करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है।

## लागत का अर्थ

आवश्यक दवा का अर्थ केवल सबसे सस्ती दवा नहीं है। लाभ, सुरक्षा, जरूरत और पूरे उपचार की लागत साथ समझनी चाहिए।

## परिवार की भूमिका

निर्देश समझना, दवाओं की जानकारी सुरक्षित रखना और समस्या होने पर संबंधित पेशेवर से संपर्क उपयोगी है।

> प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए गुणवत्तापूर्ण दवा की उपलब्धता और विवेकपूर्ण उपयोग दोनों आवश्यक हैं।

# स्वास्थ्य देखभाल का समग्र दायरा

Comprehensive Health Care

| सेवा का प्रकार | प्रमुख उद्देश्य | उदाहरण |
|---|---|---|
| स्वास्थ्य संवर्धन (**Promotion**) | बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्षमता और परिस्थिति | पोषण तथा गतिविधि के लिए सहयोग |
| रोकथाम (**Prevention**) | रोग और जोखिम को कम करना | टीकाकरण और जोखिम नियंत्रण |
| उपचार (**Treatment**) | बीमारी का उपयुक्त प्रबंधन | योग्य आकलन के अनुसार चिकित्सा |
| पुनर्वास (**Rehabilitation**) | कार्यक्षमता और सहभागिता में सुधार | दैनिक गतिविधि तथा कौशल का सहयोग |
| उपशामक देखभाल (**Palliative Care**) | गंभीर बीमारी में पीड़ा और कष्ट कम करना | लक्षण तथा परिवार की जरूरतों का सहयोग |

## एक व्यक्ति, कई जरूरतें

दीर्घकालीन रोग वाला व्यक्ति उपचार के साथ मानसिक सहयोग, जीवनशैली की सुविधा और कभी पुनर्वास की जरूरत रख सकता है। केवल रोग का नाम देखकर सेवा तय करना अधूरा हो सकता है।

## उपशामक देखभाल का अर्थ

यह केवल जीवन के अंतिम क्षणों का विषय नहीं है। जरूरत के अनुसार अन्य उपचार के साथ भी कष्ट कम करने वाली देखभाल जुड़ सकती है।

## समग्र और चयनित कार्य

किसी एक रोग पर केंद्रित कार्यक्रम उपयोगी हो सकता है, लेकिन समग्र व्यवस्था व्यक्ति की संबंधित जरूरतों के बीच संपर्क बनाए रखती है।

> प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा रोकथाम से उपचार और पुनर्वास तक सेवा की निरंतर दिशा बनाती है।

# रोकथाम के स्तर

Levels of Prevention

## रोग की प्रक्रिया के अनुसार रोकथाम

रोकथाम के स्तर बताते हैं कि कार्रवाई रोग और उसके परिणाम की किस अवस्था पर केंद्रित है। यह वर्गीकरण स्वास्थ्य सेवा के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संस्थागत स्तर से अलग है।

| स्तर | प्रमुख उद्देश्य | उदाहरण |
|---|---|---|
| प्राथमिक रोकथाम (**Primary Prevention**) | रोग होने से पहले जोखिम कम करना | टीकाकरण तथा धूम्रपान से बचाव |
| द्वितीयक रोकथाम (**Secondary Prevention**) | शुरुआती पहचान और समय पर कार्रवाई | उपयुक्त स्क्रीनिंग तथा आगे की जाँच |
| तृतीयक रोकथाम (**Tertiary Prevention**) | जटिलता और अक्षमता का प्रभाव कम करना | रोग प्रबंधन और पुनर्वास |

## स्क्रीनिंग और निदान

स्क्रीनिंग (**Screening**) से चुने हुए समूह में संभावित जोखिम या रोग का संकेत मिल सकता है। स्क्रीनिंग परिणाम और अंतिम चिकित्सकीय निदान (**Diagnosis**) एक ही बात नहीं हैं। आवश्यक पुष्टि तथा आगे की सेवा जुड़ी होनी चाहिए।

## महत्वपूर्ण उदाहरण

स्थानीय प्राथमिक केंद्र में गैर-संचारी रोग की स्क्रीनिंग हो सकती है। वह सेवा स्थान के अनुसार प्राथमिक देखभाल का भाग है, जबकि रोकथाम के उद्देश्य के अनुसार द्वितीयक रोकथाम में आ सकती है।

> रोकथाम का स्तर कार्रवाई के उद्देश्य से और सेवा का स्तर स्वास्थ्य व्यवस्था की भूमिका से तय होता है।

# भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था

Primary Health Services in India

## व्यापक ढाँचा

भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ समुदाय, उपकेंद्र, प्राथमिक केंद्र तथा संबंधित रेफरल व्यवस्था से जुड़ी हैं। राज्य और स्थानीय स्तर पर सेवा का वास्तविक स्वरूप क्षेत्र तथा उपलब्ध क्षमता के अनुसार अलग हो सकता है।

| स्तर | प्रमुख संबंध |
|---|---|
| परिवार और समुदाय | जानकारी, सहभागिता और सेवा से संपर्क |
| उपस्वास्थ्य केंद्र | समुदाय के निकट आधारभूत सेवाएँ |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | प्रथम संपर्क, सामान्य देखभाल और समन्वय |
| रेफरल संस्थाएँ | उच्चतर जाँच, उपचार और विशेषज्ञ सेवा |

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (**National Health Mission**; **NHM**) स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से जुड़ा ढाँचा है। इसे प्रत्येक केंद्र का नाम या पूरे प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा दृष्टिकोण का पर्याय नहीं कहा जाता।

## संस्थान और संकल्पना

**Primary Health Centre** एक संस्थान है। **Primary Health Care** सेवा तथा समाज के सहयोग की व्यापक संकल्पना है। उपकेंद्र, समुदाय और रेफरल संस्था भी इस दिशा में योगदान देते हैं।

## गुणवत्तापूर्ण सेवा

कर्मचारी, दवा, जाँच, जानकारी, परिवहन और आगे की देखभाल उपलब्ध हों, तभी भवन प्रभावी सेवा में बदलता है।

> भारत की स्थानीय सेवा व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को लागू करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

# आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवाएँ

Ayushman Arogya Mandir: Service Packages

## समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (**Ayushman Arogya Mandir**; **AAM**), पहले **Health and Wellness Centre** नाम से जाने जाने वाले केंद्र, समुदाय के निकट समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हैं। सेवा विस्तार में बारह प्रमुख पैकेज शामिल हैं।

| क्रम | सेवा-पैकेज का प्रमुख क्षेत्र |
|---|---|
| 1 | गर्भावस्था और प्रसव संबंधी देखभाल |
| 2 | नवजात तथा शिशु स्वास्थ्य |
| 3 | बाल और किशोर स्वास्थ्य |
| 4 | परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य |
| 5 | राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े संचारी रोग |
| 6 | सामान्य संचारी रोग और सामान्य बाह्य रोगी देखभाल |
| 7 | गैर-संचारी रोग तथा **TB** और कुष्ठ जैसे दीर्घकालीन संचारी रोग |
| 8 | आधारभूत मुख स्वास्थ्य |
| 9 | सामान्य नेत्र तथा कान, नाक और गले की समस्याएँ |
| 10 | वृद्ध और उपशामक देखभाल |
| 11 | आपात चिकित्सा सेवाएँ |
| 12 | मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग और आधारभूत प्रबंधन |

## सेवा का स्तर

स्थानीय क्षमता, निर्धारित कार्यक्षेत्र तथा रेफरल के अनुसार सेवा दी जाती है। हर केंद्र में हर विशेषज्ञ उपचार या जटिल प्रक्रिया उपलब्ध होना इस सूची का अर्थ नहीं है।

> आठ ऐतिहासिक आवश्यक घटक और बारह भारतीय सेवा-पैकेज अलग संदर्भ की सूचियाँ हैं।

# स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर और भूमिका

Health Facilities and Levels of Care

| संस्थान | सेवा व्यवस्था में प्रमुख दिशा |
|---|---|
| उपस्वास्थ्य केंद्र (**Sub Health Centre**) | समुदाय के निकट आधारभूत तथा निर्धारित प्राथमिक सेवाएँ |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (**Primary Health Centre**) | सामान्य प्रथम संपर्क देखभाल तथा स्थानीय सेवाओं का सहयोग |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (**Community Health Centre**) | निर्धारित क्षमता के अनुसार रेफरल और उच्चतर सेवाएँ |
| उपजिला तथा जिला अस्पताल | अधिक विस्तृत जाँच, उपचार और विशेषज्ञ सेवाएँ |
| उच्चतर विशेषज्ञ संस्थान | जटिल तथा विशिष्ट देखभाल |

## सेवा और वास्तविक क्षमता

संस्थान का नाम उसकी अपेक्षित भूमिका बताता है। किसी दिन उपलब्ध कर्मचारी, उपकरण, जाँच और आपात व्यवस्था उसकी वास्तविक क्षमता को प्रभावित करते हैं।

## ग्रामीण और शहरी व्यवस्था

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संस्थान और पहुँच की व्यवस्था अलग संदर्भ में विकसित होती है। जनसंख्या का घनत्व, दूरी और स्थानीय जोखिम सेवा की योजना में महत्वपूर्ण हैं।

## रेफरल की दिशा

सभी रोगियों को हर स्तर से क्रमशः गुजरना जरूरी नहीं है। गंभीरता और आवश्यक सेवा के अनुसार व्यक्ति को सीधे उपयुक्त संस्थान तक पहुँचाना आवश्यक हो सकता है।

> केंद्र का सही चयन समस्या की गंभीरता और वहाँ उपलब्ध सेवा से जुड़ा है।

# रेफरल और आगे की देखभाल

Referral and Follow-up Care

## रेफरल की संकल्पना

रेफरल (**Referral**) में व्यक्ति को ऐसी सेवा से जोड़ा जाता है जहाँ आवश्यक जाँच, विशेषज्ञता या उपचार उपलब्ध हो। यह प्राथमिक सेवा और उच्चतर देखभाल के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

## रेफरल की प्रमुख प्रक्रिया

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **जरूरत पहचानना** | गंभीरता और उपलब्ध क्षमता का आकलन। |
| 2 | **उपयुक्त सेवा चुनना** | आवश्यक विशेषज्ञता वाले संस्थान से संपर्क। |
| 3 | **पहुँच सुनिश्चित करना** | उचित सूचना और परिवहन का सहयोग। |
| 4 | **अनुवर्ती संपर्क** | आगे की देखभाल के लिए स्थानीय सेवा से जुड़ना। |

## सूचना और परिवहन

आवश्यक जानकारी तथा उपलब्ध परिवहन की व्यवस्था देरी कम कर सकती है। गंभीर स्थिति में अनावश्यक औपचारिकता या हर छोटे केंद्र पर रुकना उचित नहीं है।

## वापस जुड़ने का महत्त्व

उच्चतर संस्थान से उपचार के बाद स्थानीय सेवा को उपयुक्त जानकारी मिलना जरूरी है। इससे दवा, अनुवर्ती जाँच और देखभाल में निरंतरता रहती है। इसे वापस रेफरल (**Back Referral**) की दिशा में समझा जा सकता है।

## रेफरल पूरा होना

केवल पर्ची लिख देना और व्यक्ति का वास्तव में आवश्यक सेवा तक पहुँचना अलग बातें हैं। परिवार की बाधाएँ तथा आगे की प्रतिक्रिया भी देखें।

> सुरक्षित रेफरल में सही समय, सही स्थान, उचित सूचना और अनुवर्ती संपर्क शामिल हैं।

# प्राथमिक स्वास्थ्य दल और समुदाय कार्यकर्ता

Primary Health Care Teams

| सदस्य | प्रमुख योगदान |
|---|---|
| चिकित्सक | चिकित्सकीय आकलन, उपचार तथा सेवा समन्वय |
| नर्स और **ANM** | निर्धारित कौशल के अनुसार देखभाल और सामुदायिक सेवाएँ |
| सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (**CHO**) | निर्धारित प्राथमिक सेवा तथा दल का सहयोग |
| **ASHA** | समुदाय को जानकारी, सहभागिता और सेवाओं से जोड़ना |
| बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (**MPW**) | निर्धारित रोकथाम और समुदाय संबंधी कार्य |
| फार्मासिस्ट और तकनीशियन | दवा तथा जाँच से संबंधित पेशेवर कार्य |
| आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (**AWW**) | पोषण, बाल विकास और संबंधित समुदाय सहयोग |

## प्रमुख पदनाम

**ANM: Auxiliary Nurse Midwife; ASHA: Accredited Social Health Activist; CHO: Community Health Officer; MPW: Multipurpose Worker; AWW: Anganwadi Worker.**

## अलग भूमिका, साझा उद्देश्य

**ASHA, ANM** और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारियाँ एक जैसी नहीं हैं। स्वास्थ्य, पोषण और परिवार से जुड़ी जरूरत में उनका सहयोग उपयोगी है।

## अधिकार और प्रशिक्षण

कार्य का दायरा संबंधित प्रशिक्षण, कार्यक्रम और अधिकृत भूमिका के अनुसार होता है। स्वास्थ्य दल का सदस्य होना हर प्रकार का निदान या दवा लिखने का अधिकार नहीं देता।

## पर्यवेक्षण और क्षमता

प्रशिक्षण, आवश्यक सामग्री, उचित पर्यवेक्षण और समस्या पर सहायता मिलने से दल की गुणवत्ता बढ़ती है।

> प्रभावी दल में भूमिकाएँ स्पष्ट हों और व्यक्ति की जरूरत के अनुसार काम जुड़ा रहे।

# परिवार और स्थानीय समुदाय की भूमिका

Families and Community Participation

## परिवार की भूमिका

परिवार स्वास्थ्य जानकारी समझने, भोजन और देखभाल, अभिलेख रखने तथा जरूरत पर सेवा तक पहुँचने में सहयोग करता है। सहायता व्यक्ति की राय और गोपनीयता का सम्मान करते हुए होनी चाहिए।

## स्थानीय भागीदारी के माध्यम

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (**Village Health Sanitation and Nutrition Committee**; **VHSNC**), जन आरोग्य समिति तथा शहरी सामुदायिक मंच स्थानीय समस्याओं और सेवा से संवाद के माध्यम हो सकते हैं।

| क्षेत्र | सहभागिता का उदाहरण |
|---|---|
| जरूरत पहचानना | पानी, पोषण और सेवा की बाधा बताना |
| योजना | सुविधाजनक समय और प्राथमिकता पर सुझाव |
| कार्य | जागरूकता, स्थानीय सहयोग और सेवा से संपर्क |
| समीक्षा | गुणवत्ता, छूटे समूह तथा शिकायत पर प्रतिक्रिया |

## व्यक्ति की स्वायत्तता

समुदाय की भागीदारी के नाम पर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी सार्वजनिक करना या निर्णय में दबाव डालना उचित नहीं है। भागीदारी और गोपनीयता साथ बनी रहनी चाहिए।

## सार्वजनिक जवाबदेही

लोगों की शिकायत और अनुभव को सुनने से सेवा सुधार का अवसर मिलता है। शिकायत करने वाले को अपमानित करना सहभागिता को कमजोर करता है।

> परिवार और समुदाय सेवा के सहयोगी हैं; योग्य चिकित्सा और सार्वजनिक जिम्मेदारी का पूरा विकल्प नहीं।

# व्यक्ति-केंद्रित और निरंतर देखभाल

People-Centred and Continuous Care

## व्यक्ति-केंद्रित सेवा

व्यक्ति-केंद्रित देखभाल (**People-Centred Care**) में रोग के साथ व्यक्ति की प्राथमिकता, भाषा, परिवार, काम और सामाजिक परिस्थिति को समझा जाता है। उसे निर्णय तथा जानकारी में उचित भागीदारी मिलती है।

## प्राथमिक देखभाल के प्रमुख गुण

| गुण | प्रमुख अर्थ |
|---|---|
| प्रथम संपर्क (**First Contact**) | जरूरत पर सुगम प्रारंभिक सेवा |
| निरंतरता (**Continuity**) | समय के साथ जुड़े अभिलेख और देखभाल |
| व्यापकता (**Comprehensiveness**) | संबंधित सामान्य जरूरतों पर ध्यान |
| समन्वय (**Coordination**) | अलग सेवाओं और स्तरों को जोड़ना |

## दीर्घकालीन रोग का उदाहरण

मधुमेह वाला व्यक्ति केवल एक बार की जाँच नहीं, नियमित समीक्षा, आवश्यक उपचार और व्यवहार्य जीवनशैली सहयोग चाहता है। उच्चतर सेवा तथा स्थानीय अनुवर्ती देखभाल का संबंध भी महत्वपूर्ण है।

## मानसिक और सामाजिक पक्ष

तनाव, अकेलापन या आर्थिक कठिनाई उपचार का पालन प्रभावित कर सकती है। जरूरत के अनुसार संबंधित सहायता से संपर्क बनाया जा सकता है।

## अभिलेख का उपयोग

उचित जानकारी बार-बार अनावश्यक जाँच और परस्पर विरोधी निर्देश कम करने में सहायता देती है। जानकारी साझा करना गोपनीयता की उचित व्यवस्था में हो।

> निरंतरता का अर्थ व्यक्ति की देखभाल जुड़ी रहना है; हर सेवा एक ही कार्यकर्ता दे, यह आवश्यक नहीं।

# गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा

Quality and Patient Safety

## गुणवत्ता के प्रमुख आयाम

| आयाम | सेवा में अर्थ |
|---|---|
| प्रभावी (**Effective**) | प्रमाण और आवश्यकता के अनुसार उपयोगी सेवा |
| सुरक्षित (**Safe**) | अनावश्यक नुकसान का जोखिम कम करना |
| व्यक्ति-केंद्रित | जरूरत, सम्मान और पसंद पर ध्यान |
| समय पर (**Timely**) | अनावश्यक प्रतीक्षा और हानिकारक देरी कम करना |
| न्यायसंगत (**Equitable**) | पहचान या स्थिति से गुणवत्ता में भेदभाव नहीं |
| एकीकृत (**Integrated**) | स्तरों और सेवाओं के बीच संबंध |
| कुशल (**Efficient**) | संसाधनों का उपयोगी और जिम्मेदार उपयोग |

## सुरक्षा के व्यावहारिक पक्ष

व्यक्ति की सही पहचान, दवा संबंधी उपयुक्त जानकारी, संक्रमण नियंत्रण, सुरक्षित उपकरण और स्पष्ट रेफरल महत्वपूर्ण हैं। समस्या या गलती की समीक्षा से व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए।

## केवल उपलब्धता पर्याप्त नहीं

पास में केंद्र होने के बावजूद वहाँ आवश्यक दवा, प्रशिक्षित कर्मचारी या सम्मानपूर्ण व्यवहार न हो तो प्रभावी पहुँच सीमित रह सकती है।

## सतत सुधार

कार्यकर्ताओं और लोगों की प्रतिक्रिया, सेवा संबंधी जानकारी तथा गुणवत्ता की नियमित समीक्षा से सुधार किया जाता है।

> प्राथमिक सेवा भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए; “प्राथमिक” शब्द कम गुणवत्ता का संकेत नहीं है।

# सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और वित्तीय सुरक्षा

Universal Health Coverage and Financial Protection

## सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (**Universal Health Coverage**; **UHC**) का उद्देश्य सभी लोगों को उनकी जरूरत की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ आवश्यक समय और स्थान पर उपलब्ध कराना है, बिना वित्तीय कठिनाई में धकेले।

## संबंधित आयाम

| आयाम | प्रमुख विचार |
|---|---|
| जनसमूह | कौन सेवा तक पहुँच रहा है और कौन छूट रहा है? |
| सेवा | कौन-सी जरूरी सेवाएँ और किस गुणवत्ता से मिल रही हैं? |
| वित्तीय सुरक्षा | सेवा पाने में परिवार पर कितना आर्थिक बोझ है? |

## प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का योगदान

स्थानीय रोकथाम, प्रथम संपर्क, नियमित देखभाल और समय पर रेफरल अनावश्यक देरी तथा संबंधित खर्च कम करने में सहयोग कर सकते हैं। फिर भी प्राथमिक सेवा में पर्याप्त सार्वजनिक संसाधन और उचित वित्तीय व्यवस्था चाहिए।

## वहनीयता

वहनीयता (**Affordability**) केवल दवा की कीमत नहीं है। यात्रा, जाँच, सेवा के लिए समय और काम छूटने जैसी बाधाएँ भी परिवार के निर्णय को प्रभावित करती हैं।

## योजना और लक्ष्य का अंतर

कोई बीमा या सहायता योजना **UHC** की दिशा में योगदान दे सकती है, लेकिन एक योजना में नाम दर्ज होना सभी आवश्यक सेवाओं की प्रभावी पहुँच का पूर्ण प्रमाण नहीं है।

> **UHC** में सेवा तक पहुँच, गुणवत्ता और वित्तीय सुरक्षा एक साथ आवश्यक हैं।

# स्थानीय स्वास्थ्य योजना की प्रक्रिया

Local Health Planning

## योजना के चरण

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आकलन | समस्या, बाधा और स्थानीय जानकारी समझना। |
| 2 | प्राथमिकता | जरूरत के अनुसार उद्देश्य तथा कार्रवाई तय करना। |
| 3 | संसाधन | कर्मचारी, सामग्री और साझेदारी जोड़ना। |
| 4 | कार्य | निर्धारित भूमिका और गुणवत्तापूर्ण सेवा। |
| 5 | समीक्षा | परिणाम तथा समुदाय की प्रतिक्रिया से सुधार। |

## आवश्यकता और प्राथमिकता

समस्या की गंभीरता, प्रभावित समूह, सेवा की बाधा और उपलब्ध संसाधन साथ देखें। अधिक दिखने वाली समस्या हमेशा सबसे बड़ी जरूरत नहीं होती; छूटे समूह की आवाज भी सुननी चाहिए।

## उद्देश्य और गतिविधि

स्वास्थ्य बैठक करना गतिविधि है। लोगों को आवश्यक सेवा तक पहुँचाना उससे संबंधित उद्देश्य हो सकता है। योजना में वास्तविक परिणाम की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए।

## संसाधन का संबंध

कर्मचारी, दवा, जाँच, संपर्क और परिवहन को जोड़ना आवश्यक है। केवल जागरूकता बढ़ाकर सेवा उपलब्ध न कराना लोगों की अपेक्षा और विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

> स्थानीय योजना में समुदाय की जरूरत, व्यावहारिक संसाधन और परिणाम की समीक्षा साथ जुड़ते हैं।

# निगरानी और मूल्यांकन

Monitoring and Evaluation

## अलग लेकिन संबंधित कार्य

निगरानी (**Monitoring**) से कार्यक्रम की प्रगति और चलती स्थिति की जानकारी मिलती है। मूल्यांकन (**Evaluation**) में उद्देश्य, कार्य की उपयोगिता और परिणाम की व्यवस्थित समीक्षा की जाती है।

| स्तर | उदाहरणात्मक संकेतक |
|---|---|
| संसाधन (**Input**) | प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक सामग्री |
| प्रक्रिया (**Process**) | निर्धारित सेवा तथा समीक्षा की व्यवस्था |
| प्रत्यक्ष उपलब्धि (**Output**) | सेवा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या |
| परिणाम (**Outcome**) | आवश्यक अनुवर्ती सेवा का उपयोग |
| व्यापक प्रभाव (**Impact**) | समय के साथ स्वास्थ्य स्थिति में सुधार |

## संख्या से आगे

उपस्थिति अधिक होना उपयोगी है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता, संतुष्टि और छूटे समूह को भी देखना चाहिए। रोगी की संख्या बढ़ना कभी बेहतर पहचान का परिणाम भी हो सकता है; उसे सीधे स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं कहा जा सकता।

## कारण का सावधानी से आकलन

समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति पर कई कारण प्रभाव डालते हैं। केवल पहले और बाद की संख्या से पूरा बदलाव एक कार्यक्रम के कारण हुआ, यह मानना पर्याप्त नहीं है।

## जानकारी की गुणवत्ता

स्पष्ट परिभाषा, सही अभिलेख और आवश्यक गोपनीयता मूल्यांकन को उपयोगी बनाते हैं।

> समीक्षा का उद्देश्य केवल संख्या गिनना नहीं, सेवा की पहुँच और उपयोगिता सुधारना है।

# ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य जरूरतें

Rural and Urban Health Needs

## क्षेत्र के अनुसार बाधाएँ

ग्रामीण क्षेत्र में दूरी और परिवहन तथा शहरी क्षेत्र में भीड़, अस्थिर आवास और सेवा की जानकारी की कमी जैसी बाधाएँ हो सकती हैं। शहर में अस्पताल अधिक होने से हर व्यक्ति की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित नहीं होती।

| परिस्थिति | योजना में आवश्यक विचार |
|---|---|
| दूरस्थ बस्ती | स्थानीय संपर्क, परिवहन और रेफरल |
| शहरी वंचित बस्ती | पानी, स्वच्छता, सुविधाजनक सेवा और जानकारी |
| प्रवासी परिवार | अभिलेख, भाषा और सेवा की निरंतरता |
| कामकाजी समूह | समय, दूरी और काम छूटने की बाधा |
| दिव्यांग या वृद्ध व्यक्ति | सुगमता और आवश्यक सहायता |

## सामाजिक स्वीकार्यता

सेवा व्यक्ति की भाषा और परिस्थिति को समझे। स्थानीय आदत का सम्मान उपयोगी है, लेकिन असुरक्षित प्रथा को बिना समीक्षा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

## स्थानीय समाधान

सेवा समय में सुधार, समुदाय संपर्क और योग्य उच्चतर सेवा से संबंध जरूरत के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं। एक क्षेत्र की पूरी व्यवस्था दूसरे क्षेत्र में बिना बदलाव लागू करना हमेशा प्रभावी नहीं होता।

> प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा समान उद्देश्य रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यविधि अपनाती है।

# चार सिद्धांतों का संयुक्त उपयोग

Applying the Four Principles Together

## उदाहरण: बार-बार दस्त की समस्या

एक बस्ती में बच्चों को बार-बार दस्त हो रहा है। परिवारों को उपचार से जोड़ना तत्काल जरूरत है। साथ ही पानी, स्वच्छता, भोजन और सेवा की बाधाओं का आकलन आवश्यक है। यह उदाहरण योजना समझाने के लिए है।

| सिद्धांत | उदाहरण में उपयोग |
|---|---|
| न्यायसंगत वितरण | दूर और कम आय वाले परिवार तक आवश्यक सेवा |
| सामुदायिक सहभागिता | दूषण और सेवा की बाधा के बारे में स्थानीय जानकारी |
| अंतरक्षेत्रीय समन्वय | स्वास्थ्य, जल और स्थानीय प्रशासन का सहयोग |
| उपयुक्त प्रौद्योगिकी | मान्य जाँच और परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित जल उपाय |

## संबंधित सेवा-घटक

स्वास्थ्य शिक्षा, पानी-स्वच्छता, उचित उपचार और आवश्यक दवा इस काम में जुड़ सकते हैं। पोषण तथा बाल देखभाल की जरूरत भी देखें।

## परिणाम की समीक्षा

पानी की व्यवस्था, सेवा तक पहुँच और लोगों का अनुभव देखें। केवल बैठक या सामग्री वितरण की संख्या से रोग नियंत्रण की पूरी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती।

## व्यापक सीख

सिद्धांत और सेवा-घटक एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का उपचार तथा समस्या के कारणों पर कार्रवाई साथ चल सकते हैं।

> प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा में बीमारी की सेवा और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर कार्य जुड़ा रहता है।

# प्रमुख चुनौतियाँ और सुधार

Challenges and Improvements

| चुनौती | सुधार की दिशा |
|---|---|
| सेवा से दूरी | स्थानीय पहुँच, संपर्क और रेफरल परिवहन |
| कर्मचारी या कौशल की कमी | प्रशिक्षण, सहयोग और उचित कार्य वितरण |
| दवा तथा जाँच की बाधा | आपूर्ति, गुणवत्ता और संबंधित सेवाओं का समन्वय |
| कमजोर सहभागिता | समावेशी संवाद और निर्णय का वास्तविक अवसर |
| बिखरी हुई देखभाल | अभिलेख, रेफरल और अनुवर्ती संपर्क |
| आर्थिक कठिनाई | वहनीय सेवा और वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था |
| कमजोर समीक्षा | सही जानकारी और नियमित सुधार |

## आत्मनिर्भरता और सहायता

आत्मनिर्भरता (**Self-Reliance**) का अर्थ व्यक्ति तथा समुदाय की क्षमता बढ़ना है। इसका अर्थ आवश्यक सेवा का पूरा खर्च और जिम्मेदारी परिवार पर डाल देना नहीं है।

## डिजिटल अंतर

डिजिटल सुविधा उपयोगी हो सकती है, लेकिन संपर्क, उपकरण, भाषा और कौशल की कमी से कुछ लोग छूट सकते हैं। आवश्यक प्रत्यक्ष और अन्य संपर्क विकल्प बने रहने चाहिए।

## टिकाऊ सुधार

संसाधन, स्थानीय भागीदारी और निरंतर समीक्षा का संबंध सेवा को अधिक स्थायी बनाता है। अस्थायी अभियान के बाद आगे की देखभाल की योजना भी आवश्यक है।

> प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा मजबूत होने के लिए नीति, संसाधन, समुदाय और गुणवत्तापूर्ण सेवा साथ चाहिए।

# अध्याय की प्रमुख अवधारणाओं का सार

Key Concepts and Chapter Review

| अध्ययन-ढाँचा | याद रखने योग्य संबंध |
|---|---|
| चार सिद्धांत | न्यायसंगत वितरण, सहभागिता, अंतरक्षेत्रीय समन्वय, उपयुक्त तकनीक |
| आठ आवश्यक घटक | शिक्षा, पोषण, जल-स्वच्छता, मातृ-बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्थानिक रोग, उपचार, दवा |
| आधुनिक तीन घटक | एकीकृत सेवा, बहुक्षेत्रीय कार्रवाई, सशक्त समुदाय |
| भारतीय सेवा विस्तार | **AAM** के बारह प्रमुख सेवा-पैकेज |
| ऐतिहासिक दिशा | अल्मा-अता 1978 और अस्ताना 2018 |

## आवश्यक अंतर

- **Primary Health Care** व्यापक दृष्टिकोण और **Primary Health Centre** एक संस्थान है।
- प्राथमिक चिकित्सा तत्काल सहायता है; प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का दायरा अधिक व्यापक है।
- न्यायसंगतता में वास्तविक बाधा और जरूरत के अनुसार सहायता मिलती है।
- स्क्रीनिंग और अंतिम निदान अलग चरण हैं।
- रोकथाम का स्तर और संस्थागत सेवा का स्तर अलग आधार से तय होते हैं।
- रेफरल तथा वापस जुड़ने से सेवा की निरंतरता बढ़ती है।

## केंद्रीय विचार

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा व्यक्ति के दैनिक जीवन के निकट आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण सेवा लाती है। स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों पर कार्रवाई तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी से यह केवल उपचार से आगे बढ़कर पूरे समुदाय के स्वास्थ्य में योगदान देती है।

> उपयोगी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुगम, समग्र, न्यायसंगत, सुरक्षित और निरंतर देखभाल पर आधारित होती है।